

GiroSUS

PROPOSTA PARA GESTORES DO SUS · GOIÁS

Quem ocupa os leitos do SUS, por quanto tempo e quanto isso custa

Painel de Ocupação de Leitos: um retrato de toda a rede hospitalar SUS de Goiás, construído só com dado público e gratuito do Ministério da Saúde.



1,84 mi

leitos-dia pagos pelo SUS em Goiás em
2025

457 mil

internações

R\$ 726 mi

pagos pelo SUS

Fonte: SIH/SUS (DATASUS) · safra jan-dez/2025 · [Seu nome] · [Data]

PERGUNTA

Qual problema o GiroSUS resolve?

Dona Maria, 72 anos, pneumonia. Sai de Trindade de ambulância, chega a Goiânia e não tem leito. Vai para outro hospital. Cada hora na estrada é risco para ela.

O problema não é só falta de leito. É **leito parado**: em Goiás, 1 em cada 23 pacientes ocupa mais de um quarto de todos os leitos do SUS. O GiroSUS mostra onde está esse leito travado.

Caso ilustrativo. Números: SIH/SUS, Goiás, 2025.

O QUE O GRÁFICO MOSTRA

Um caso ilustrativo (Dona Maria) e o número que resume o problema: em Goiás, 1 em cada 23 pacientes ocupa mais de um quarto de todos os leitos do SUS. Falta de vaga não é só falta de leito, é também leito parado.

REGRA DE NEGÓCIO

"1 em cada 23 pacientes" são as internações de mais de 15 dias (4,4% das internações da safra 2025). "Mais de um quarto dos leitos" é a parte dos leitos-dia que essas internações somam (27,3%). A história é ilustrativa; os números são do SIH/SUS, Goiás, 2025.

PERGUNTA

O que o gestor ganha com o GiroSUS?

1 · CAPACIDADE

Mais pacientes, sem abrir leito novo

Reduzir só 10% dos dias além do tempo típico libera cerca de **20 mil internações por ano**.

2 · VIDAS

Menos transferências, menos risco

Você vê de onde vêm os pacientes: **57%** dos leitos de Goiânia são de moradores de outras cidades. Planeje antes de a ambulância sair.

3 · DINHEIRO

Dinheiro que para de escapar

O SUS paga um pacote fixo. Na pneumonia, o hospital recebe **R\$ 377 por dia** quando o paciente fica 2 dias e **R\$ 64 por dia** quando fica 15.

4 · PLANEJAMENTO

Equipe pronta antes do pico

A ocupação respiratória sobe **31% em maio**. Você reforça em março, não improvisa em maio.

5 · PRESTAÇÃO DE CONTAS

Resposta na mão

Quando o Ministério Público, a imprensa ou o secretário perguntarem, você tem o número do seu hospital ou município.

SEM CUSTO DE DADOS

Nada para integrar

Usa só o que o seu hospital já envia ao SUS todo mês. Atualização mensal.

O QUE O GRÁFICO MOSTRA

Cinco ganhos para o gestor, cada um apoiado em um número do painel.

REGRA DE NEGÓCIO

Capacidade: 10% dos dias além do tempo típico, divididos pela permanência média, dão cerca de 20 mil internações. Vidas: parte dos leitos-dia de Goiânia usada por quem mora em outro município (57%). Dinheiro: na pneumonia sem UTI, valor pago dividido pelos dias internado (R\$ 377 por dia em 2 dias, R\$ 64 em 15). Planejamento: ocupação média do respiratório em maio comparada com a média do ano (+31%). Prestação de contas: todo número pode ser filtrado por hospital ou município. Sem custo de dados: usa só o SIH/SUS, público e gratuito.

PARA QUE SERVE

O TAMANHO DA REDE E AS DESCOBERTAS

PERGUNTA

Qual é o tamanho da rede SUS em Goiás em 2025?

1,84 mi

leitos-dia

457 mil

internações

4,0 dias

permanência média

R\$ 726 mi

pagos pelo SUS

R\$ 396

por leito-dia

O QUE O GRÁFICO MOSTRA

Cinco números que resumem a safra 2025. Contar internações esconde o que pesa na rede: um paciente de 30 dias ocupa o mesmo leito que dez pacientes de 3 dias. Por isso o painel mede em leito-dia.

REGRA DE NEGÓCIO

Leitos-dia: soma dos dias que cada paciente ficou internado. Internações: AIHs novas (sem as de continuação) apresentadas ao SUS de janeiro a dezembro de 2025. Permanência média: leitos-dia ÷ internações. Valor pago: o que o SUS pagou, não o custo real do hospital. R\$ por leito-dia: valor pago ÷ leitos-dia.

PERGUNTA

O que o painel já mostra logo de cara?

DESCOMPASSO**O respiratório ocupa mais leito do que recebe**

12,5% dos leitos-dia e 8,9% do valor pago. O circulatório é o contrário: 11,9% dos leitos e 21% do dinheiro.

CONCENTRAÇÃO**4,4% dos pacientes ocupam 27% dos leitos**

São as internações de mais de 15 dias. É onde o giro de leito trava.

DEPENDÊNCIA**Goiânia tem 45% dos leitos-dia do estado**

E 57% dos leitos usados na capital são de moradores de outras cidades.

O QUE O GRÁFICO MOSTRA

Três achados: descompasso (quem ocupa leito não é quem recebe o dinheiro), concentração (poucos pacientes ocupam muitos leitos) e dependência (Goiânia recebe pacientes de todo o estado).

REGRA DE NEGÓCIO

Descompasso: compara, para cada grupo de doença, a parte dos leitos-dia com a parte do valor pago. Concentração: internações de mais de 15 dias. Dependência: parte dos leitos-dia que fica em hospitais de Goiânia e, dentro dela, a parte usada por quem mora em outro município (município de residência diferente do município do hospital).

PARA QUE SERVE

PARA QUEM E QUANTO SE GANHA

PERGUNTA Quem usa o GiroSUS, e para quê?

Diretor de hospital

Saber onde o leito está travado, quanto cada dia rende e em que dia da semana o hospital enche.

Secretaria Estadual

Ver quais hospitais e municípios consomem mais leito e quem depende de quem, para decidir onde investir.

Secretaria Municipal

Quanto leito os seus moradores usam, onde são internados e quanto isso custa ao SUS.

O QUE O GRÁFICO MOSTRA

O que cada gestor encontra no painel.

REGRA DE NEGÓCIO

Diretor de hospital: filtra o próprio hospital (pelo código CNES) e vê dias acima do típico, R\$ por dia e o dia da semana em que o hospital enche. Secretaria estadual: compara hospitais e municípios e vê quem depende de quem. Secretaria municipal: filtra pelo município de residência dos pacientes e vê onde eles são internados e quanto custam.

PERGUNTA Quanto se ganharia reduzindo os dias além do típico?

GANHO ESTIMADO

Reduzir só 10% dos dias acima do tempo típico libera ~80 mil leitos-dia por ano: cerca de 20 mil internações a mais com os mesmos leitos.

GIROSUS

“Seu leito é pago por pacote, mas ocupado por dia. O GiroSUS mostra onde esses dias estão, para a próxima Dona Maria encontrar vaga.”

O QUE O GRÁFICO MOSTRA

A capacidade que a rede ganharia sem abrir leito novo, se os pacientes que passam do tempo típico saíssem um pouco antes.

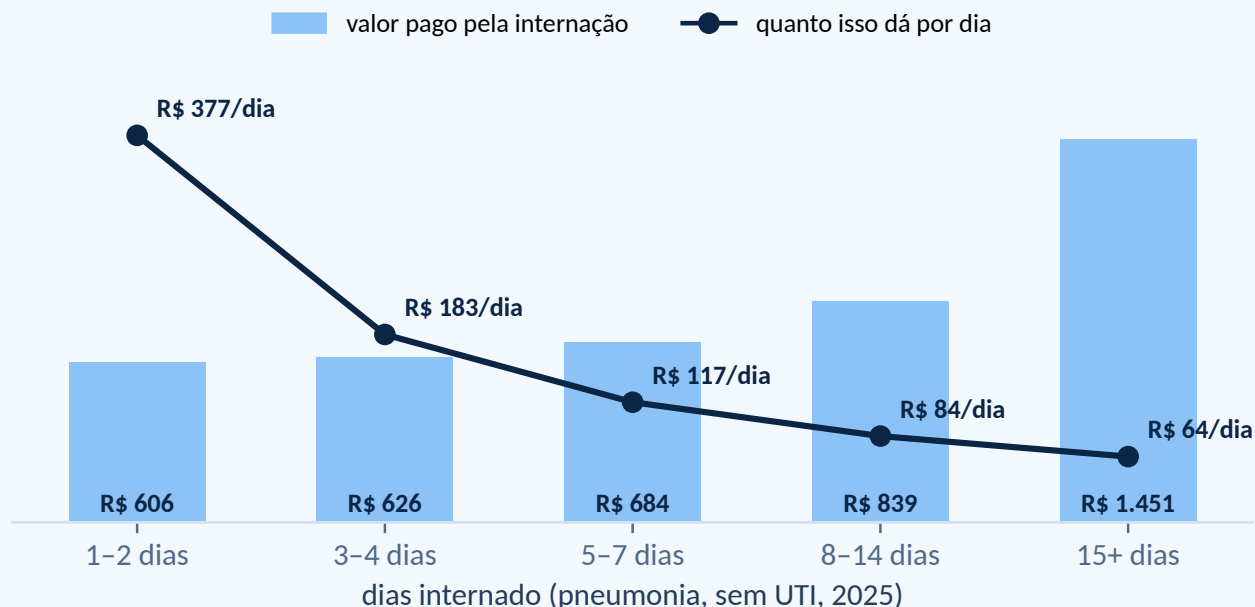
REGRA DE NEGÓCIO

Tempo típico: mediana de dias do mesmo procedimento em 2025 (não é puxada por casos extremos). Dias acima do típico: dias internado menos o tempo típico; se ficou menos, conta zero. Em 2025 somaram 806 mil leitos-dia. Reduzir 10% libera cerca de 80 mil leitos-dia, que divididos pela permanência média (4,0 dias) dão cerca de 20 mil internações. É uma estimativa de capacidade, não uma promessa; o percentual é ajustável no simulador do painel.

CURIOSIDADE

COMO O SUS PAGA UMA INTERNAÇÃO

PERGUNTA

Quanto o SUS paga por uma internação de pneumonia, conforme o tempo internado?**Pneumonia sem UTI em Goiás, 2025: valor pago e quanto isso dá por dia**

Quem fica 1-2 dias rende R\$ 377 por dia ao hospital; quem fica 15 dias ou mais, R\$ 64 por dia. O valor da internação sobe pouco; os dias a mais pesam no caixa do hospital.

O QUE O GRÁFICO MOSTRA

As colunas mostram o valor médio pago por internação em cada faixa de dias; a linha mostra quanto isso dá por dia. O valor da internação sobe pouco (de R\$ 606 para R\$ 1.451), mas o valor por dia cai de R\$ 377 para R\$ 64.

REGRA DE NEGÓCIO

O SUS paga um pacote fixo por procedimento (tabela nacional SIGTAP), não por dia. Aqui entra só o procedimento de pneumonia ou gripe, sem passagem pela UTI. Valor por dia = valor pago ÷ dias internado, dentro de cada faixa. Os dias a mais pesam no caixa do hospital.

CURIOSIDADE

COMO O SUS PAGA UMA INTERNAÇÃO

PERGUNTA

O que o SUS paga por dia, fora do pacote?

UTI

R\$ 631 por dia de UTI

A diária de UTI é paga à parte. Em 2025 a UTI somou R\$ 176 milhões, 24% de tudo o que o SUS pagou em internações em Goiás.

SAÚDE MENTAL

R\$ 82 por dia

A internação psiquiátrica é paga por dia. Por isso o valor cresce junto com a permanência, ao contrário da pneumonia.

ACOMPANHANTE

Diárias em 52% das internações

Quando a lei garante acompanhante (crianças, idosos, gestantes), o SUS paga diárias extras.

Os valores são os da tabela federal registrados no SIH. Estados e municípios podem pagar complementos que nem sempre aparecem nessa base.

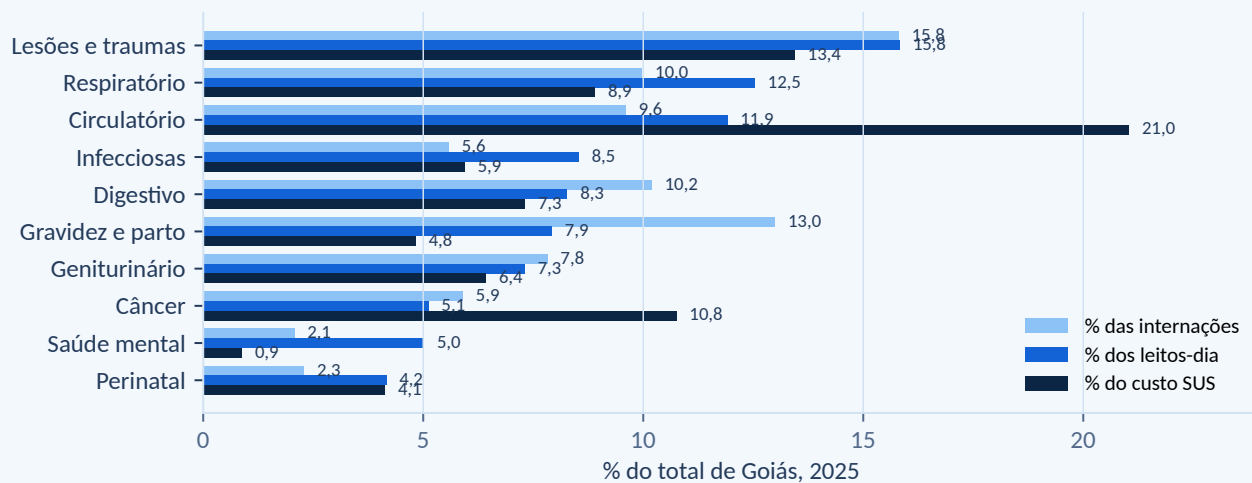
O QUE O GRÁFICO MOSTRA

As três exceções ao pacote fixo: UTI, saúde mental e diárias de acompanhante.

REGRA DE NEGÓCIO

UTI: valor pago pela UTI ÷ dias de UTI (R\$ 631 por dia; R\$ 176 milhões, 24% de tudo o que o SUS pagou). Saúde mental: valor pago ÷ dias internado no procedimento psiquiátrico (R\$ 82 por dia). Acompanhante: parte das internações com diária de acompanhante paga (52%). São os valores da tabela federal registrados no SIH; complementos de estados e municípios podem não aparecer.

PERGUNTA

Quais doenças ocupam mais leito, e isso bate com o que custam?**Três lentes por grupo de doença**

Barra do meio (leitos-dia) maior que a escura (custo): o grupo ocupa mais leito do que recebe.

O QUE O GRÁFICO MOSTRA

Para cada grupo de doença, três barras: parte das internações, parte dos leitos-dia e parte do valor pago. Quando a barra de leitos-dia é maior que a de custo, o grupo ocupa mais leito do que recebe.

REGRA DE NEGÓCIO

Grupo de doença pela primeira letra do diagnóstico principal (CID-10): J = respiratório, I = circulatório, S e T = lesões e traumas... Cada parte é calculada sobre o total de Goiás na safra 2025.

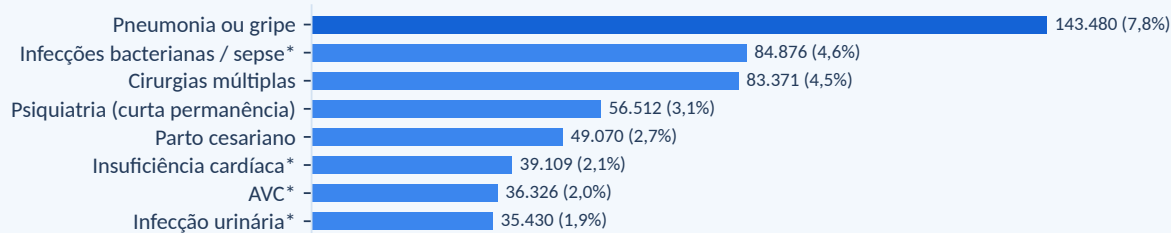
PERGUNTAS QUE RESPONDE

P7	Qual doença ocupa mais leito?	Lesões e traumas: 290.559 leitos-dia (15,8%).
P8	Quem ocupa mais leito do que recebe?	Respiratório (12,5% dos leitos, 8,9% do valor) e saúde mental (5,0% e 0,9%).
P9	Quem recebe mais do que ocupa?	Circulatório (11,9% e 21,0%) e câncer (5,1% e 10,8%).

PERGUNTA

Quais procedimentos mais ocupam leito?

Procedimentos que mais ocupam leito



* Nome pelo diagnóstico principal mais comum. Conferir o nome oficial no SIGTAP.

O QUE O GRÁFICO MOSTRA

Os 8 procedimentos com mais leitos-dia na safra 2025 e a parte de cada um no total do estado.

REGRA DE NEGÓCIO

Procedimento é o realizado na internação (tabela SIGTAP). O nome mostrado vem do diagnóstico mais comum daquele procedimento; os marcados com * devem ser conferidos no SIGTAP.

PERGUNTAS QUE RESPONDE

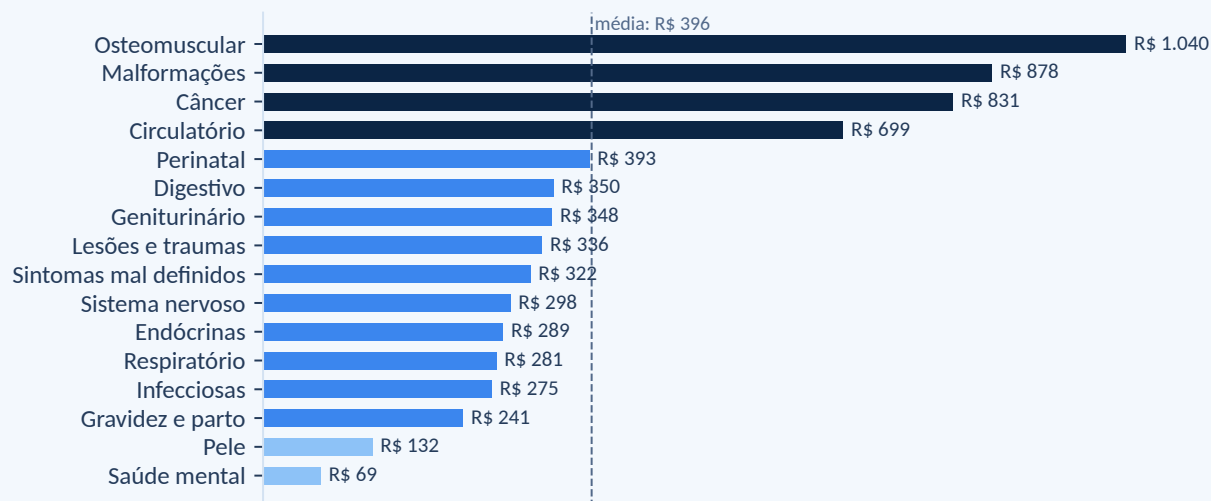
P10 Qual procedimento ocupa mais leito?

Tratamento de pneumonia ou gripe: 143.480 leitos-dia (7,8%).

PERGUNTA

Quanto o SUS paga por cada dia de leito, em cada doença?

Valor pago pelo SUS por leito-dia



Valor pago pelo SUS, não o custo real do hospital.

O QUE O GRÁFICO MOSTRA

Quanto o SUS pagou, em média, por dia de leito em cada grupo de doença. A linha pontilhada é a média do estado (R\$ 396).

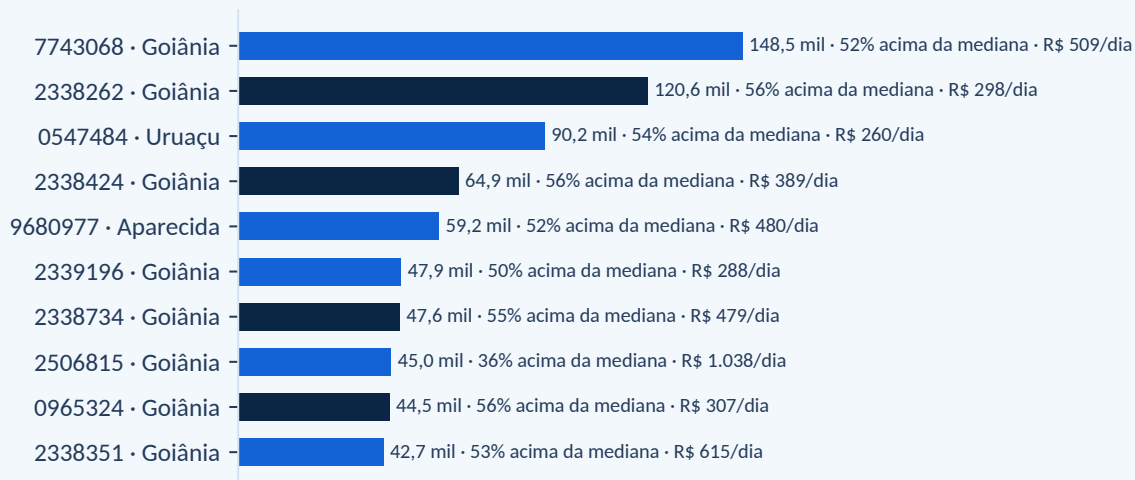
REGRA DE NEGÓCIO

R\$ por leito-dia = valor pago do grupo ÷ leitos-dia do grupo. Valor pago pelo SUS não é o custo real do hospital. O gasto por mês (P23) usa o mês em que o hospital apresentou a conta ao SUS (a competência), não o mês da internação.

PERGUNTAS QUE RESPONDE

P19	Onde o SUS gasta mais, em reais?	Circulatório (R\$ 152,8 mi), traumas (R\$ 97,6 mi) e câncer (R\$ 78,1 mi).
P20	Qual internação é mais cara?	Malformações (R\$ 4.416), osteomuscular (R\$ 3.567) e circulatório (R\$ 3.479) por internação.
P21	Qual doença rende mais por dia de leito?	Osteomuscular (R\$ 1.040), câncer (R\$ 831) e circulatório (R\$ 699).
P22	E qual rende menos?	Saúde mental (R\$ 69) e pele (R\$ 132).
P23	O gasto muda ao longo do ano?	Pouco: de R\$ 55,9 mi (fev) a R\$ 64,6 mi (jul) por mês.

PERGUNTA

Quais hospitais consomem mais leite, e quanto recebem por dia?**Os 10 hospitais com mais leitos-dia**

Azul escuro: 55% ou mais dos dias acima do típico. Hospitais pelo código CNES e pelo município: o SIH não tem o nome do hospital.

O QUE O GRÁFICO MOSTRA

Os 10 hospitais com mais leitos-dia em 2025. Cada rótulo traz: mil leitos-dia · % dos dias acima do típico · R\$ por leito-dia. Azul escuro marca os hospitais com 55% ou mais dos dias acima do típico.

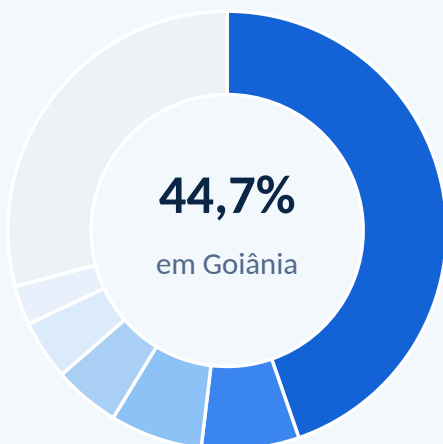
REGRA DE NEGÓCIO

O hospital aparece pelo código CNES e pelo município: o SIH não traz o nome do hospital. % acima do típico = dias acima do típico ÷ leitos-dia do hospital. R\$ por leito-dia = valor pago ÷ leitos-dia do hospital.

PERGUNTAS QUE RESPONDE

P11	Quais hospitais consomem mais leite?	7743068 (Goiânia, 148.490), 2338262 (Goiânia, 120.561) e 0547484 (Uruaçu, 90.241).
P12	Quanto os 10 maiores concentram?	711 mil leitos-dia, 38,7% do estado, entre 260 hospitais.
P13	Quanto cada hospital recebe por leito-dia?	De R\$ 260 (0547484) a R\$ 1.038 (2506815) entre os 10 maiores.

PERGUNTA

Em quais cidades ficam os leitos usados?**Onde ficam os leitos-dia usados****O QUE O GRÁFICO MOSTRA**

A rosca divide os leitos-dia do estado pelo município onde fica o hospital. Goiânia concentra 44,7%.

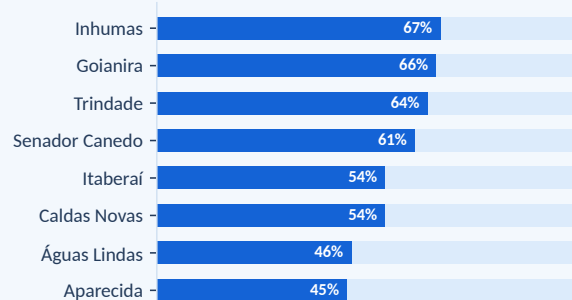
REGRA DE NEGÓCIO

Usa o município do hospital (município de atendimento). Dentro de Goiânia, "quem mora fora" é o paciente cujo município de residência é outro.

PERGUNTAS QUE RESPONDE

P14	Em quais cidades ficam os leitos usados?	Goiânia (44,7%), Aparecida (7,2%), Anápolis (6,8%), Uruaçu (4,9%), Rio Verde (4,4%).
P16	Quanto dos leitos de Goiânia é de quem mora fora?	57%.

PERGUNTA

Quem mais depende de outra cidade?**Moradores internados fora de casa**

Municípios com 3.000+ internações.

O QUE O GRÁFICO MOSTRA

Para cada município, a parte das internações dos seus moradores que aconteceu em outra cidade.

REGRA DE NEGÓCIO

Usa o município de residência do paciente. Entram só municípios de Goiás com 3.000 ou mais internações, para não distorcer com cidades pequenas.

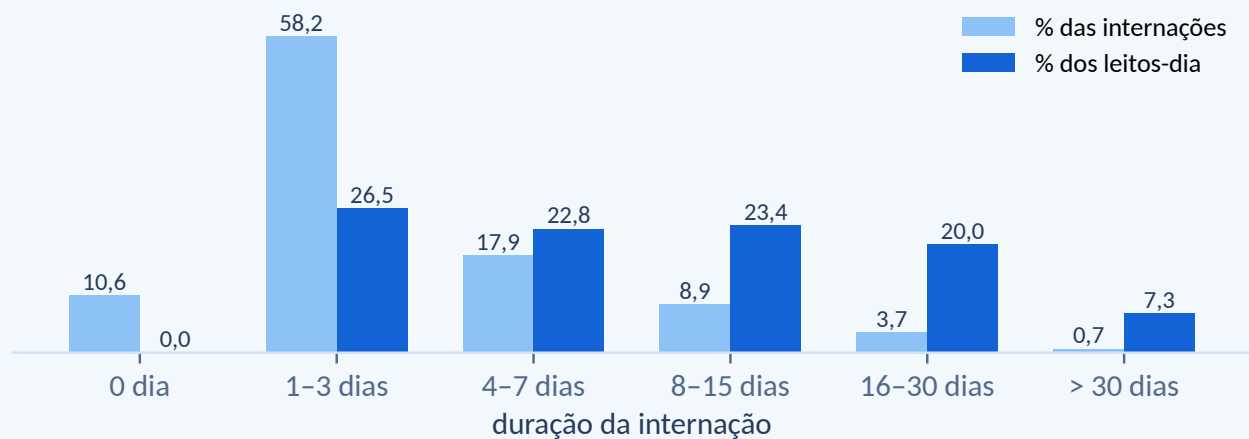
PERGUNTAS QUE RESPONDE

P15	Moradores de qual cidade mais usam leito?	Goiânia (389.462), Aparecida (165.600) e Anápolis (101.311 leitos-dia).
P17	Quem mais depende de outra cidade?	Inhumas (67%), Goianira (66%), Trindade (64%), Senador Canedo (61%).
P18	Quanto custam ao SUS os moradores de um município?	Ex.: Aparecida de Goiânia, R\$ 74,6 milhões em 2025.

PERGUNTA

Quem fica pouco e quem fica muito no leito?

Quem fica pouco e quem fica muito



O QUE O GRÁFICO MOSTRA

Para cada faixa de dias internado, duas colunas: parte das internações e parte dos leitos-dia. Poucas internações longas ocupam muitos leitos.

REGRA DE NEGÓCIO

Faixa pelos dias internado: 0 dia, 1-3, 4-7, 8-15, 16-30 e mais de 30. Internação longa é a de mais de 15 dias.

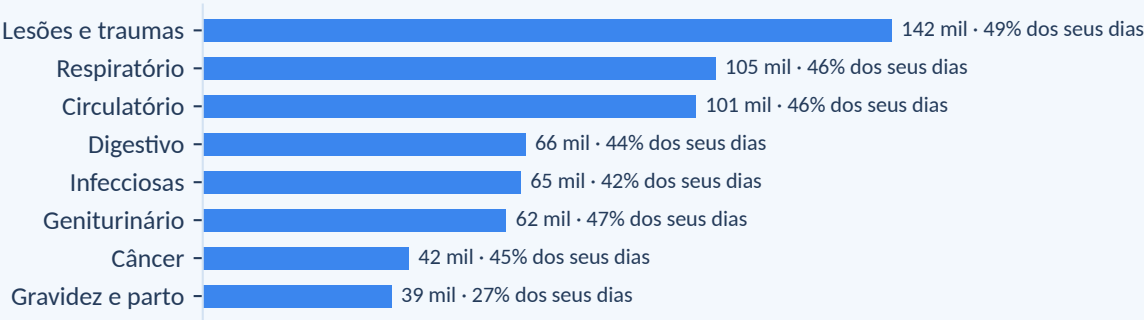
PERGUNTAS QUE RESPONDE

P26 Quanto ocupam as internações longas?

Mais de 15 dias: 4,4% das internações e 27,3% dos leitos-dia.

PERGUNTA **Em quais doenças estão os dias além do típico?**

Dias acima do tempo típico, por doença



Mil leitos-dia acima da mediana do procedimento · % dos dias do próprio grupo.

O QUE O GRÁFICO MOSTRA

Para cada grupo de doença: mil leitos-dia acima do tempo típico e quanto isso representa dos dias do próprio grupo.

REGRA DE NEGÓCIO

Tempo típico = mediana de dias do mesmo procedimento em 2025. Dias acima do típico = dias internado menos o tempo típico (se ficou menos, conta zero). Os hospitais (P27 e P28) usam a mesma regra, filtrando por hospital.

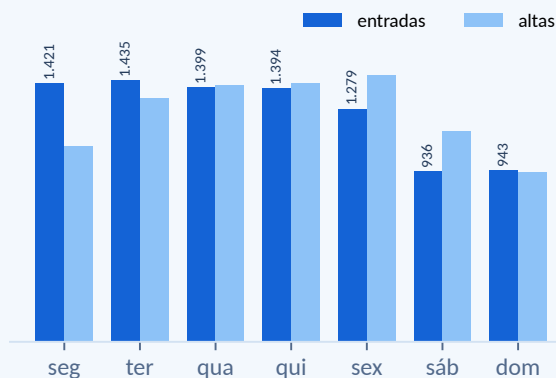
PERGUNTAS QUE RESPONDE

P24	Quantos leitos-dia ficaram acima do típico?	806.293, 44% do total.
P25	Em quais doenças estão esses dias?	Traumas (141,7 mil), respiratório (105,4 mil), circulatório (101,4 mil).
P27	Quais hospitais têm mais dias acima do típico?	0965324 (56,5%), 2338424 (56,2%), 2338262 (55,9%).
P28	Quem gira o leito mais rápido?	2506815: 3,5 dias em média e 35,9% dos dias acima do típico.

PERGUNTA

Em que dia da semana entra e sai mais gente?

Entradas e altas por dia da semana (média)



O QUE O GRÁFICO MOSTRA

Média de entradas (internações que começaram) e de altas por dia da semana em 2025.

REGRA DE NEGÓCIO

Entrada = internação que começou naquele dia; alta = internação que terminou naquele dia. A média é feita sobre os dias de 2025.

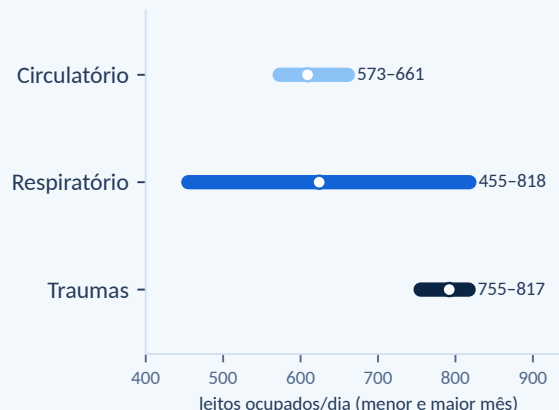
PERGUNTAS QUE RESPONDE

- P30** Em que dia da semana entra mais gente? Terça (1.435) e segunda (1.421). No fim de semana, cerca de 940.
- P31** Em que dia sai mais gente? Sexta (1.467). Domingo tem o menor número de altas (934).

PERGUNTA

Como cada doença varia ao longo do ano?

Variação no ano por doença



O QUE O GRÁFICO MOSTRA

Para três grupos, o menor e o maior mês de leitos ocupados por dia em 2025. Quanto maior a distância, mais sazonal é a doença.

REGRA DE NEGÓCIO

Internado no dia = quem já tinha entrado e ainda não tinha saído. Conta todos os dias de 2025, inclusive de pacientes cuja conta só foi apresentada ao SUS em 2026. Média por dia dentro de cada mês.

PERGUNTAS QUE RESPONDE

- P29** Em que mês os leitos enchem mais? Maio: média de 5.250 internados por dia.
- P32** Qual doença é mais sazonal? Respiratório: de 455 (dez) a 818 (mai) leitos ocupados por dia.

PERGUNTA

Quanto se ganharia agindo, e por onde começar?

RESPOSTA CURTA

O simulador do painel e a visão combinada de onde agir.

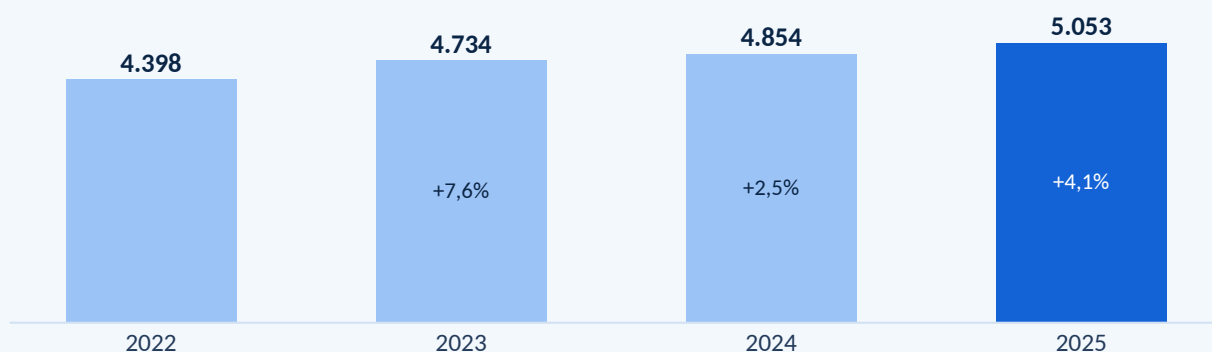
REGRA DE NEGÓCIO

10% de 806 mil leitos-dia acima do típico = 80,6 mil. Dividido pela permanência média de 4,0 dias = cerca de 20 mil internações. É capacidade liberada estimada, não uma promessa.

PERGUNTAS QUE RESPONDE

- P33** Quanto se ganharia reduzindo os dias acima do típico? 10% a menos = ~80,6 mil leitos-dia = ~20 mil internações a mais por ano.
- P34** Onde agir primeiro? Nos procedimentos e hospitais com mais dias acima do típico, nas altas de fim de semana e no preparo para maio.

PERGUNTA

A rede está crescendo ano a ano?**Pacientes internados por dia na rede, média do ano**

Dentro da barra: crescimento sobre o ano anterior. 2025, em destaque, é a safra do painel.

O QUE O GRÁFICO MOSTRA

A média de pacientes internados por dia em cada ano, de 2022 a 2025. A rede cresce todo ano: de 4.398 em 2022 para 5.053 em 2025. Serve para planejar o próximo ano sabendo que a demanda tende a subir.

REGRA DE NEGÓCIO

Mesma regra do calendário de ocupação: internado no dia = quem já tinha entrado e ainda não tinha saído, com todas as contas do SUS. O valor do ano é a média dos 12 meses; o de 2025 é o mesmo “média do ano” do mapa de sazonalidade (5.053). 2021 fica de fora porque o começo da base não tem quem entrou em 2020.

PERGUNTAS QUE RESPONDE**P29 Em que mês os leitos enchem mais?**

Maior: média de 5.250 internados por dia. E a rede cresce: +7,6% em 2023, +2,5% em 2024 e +4,1% em 2025.

PERGUNTA

Onde terei leito disponível?**RESPOSTA CURTA**

O que o GiroSUS consegue e o que não consegue dizer sobre vaga. Ele não mostra onde há leito livre hoje: o dado do SUS é mensal e chega com atraso. Ele mostra quando e onde a pressão sobre o leito é menor, para planejar.

REGRA DE NEGÓCIO

Quando a pressão é menor: dezembro e janeiro são os meses mais vazios da rede (-4,9% e -3,4% da média do ano, no mapa de sazonalidade), e o fim de semana tem menos entradas (cerca de 940 por dia, contra 1.435 na terça). Onde: hospitais e municípios com menos dias acima do típico giram o leito mais rápido (páginas de hospitais e de permanência). Para ir além, dá para cruzar com o CNES (leitos SUS cadastrados) e estimar a taxa de ocupação por hospital, com um aviso: leito cadastrado não é leito em operação.

PERGUNTA

Em que época do ano cada doença aperta a rede?

Pacientes internados por dia em 2025: quanto cada mês fica acima ou abaixo da média do ano (%)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	média/dia
Total da rede	-3,4	+1,1	+2,0	+2,8	+3,9	+2,0	-0,9	-1,2	+1,5	-0,9	-2,0	-4,9	5.053
Lesões e traumas	-4,7	-2,8	+1,8	+2,3	-2,6	+0,1	+1,9	+3,1	+1,7	+0,5	-1,0	-0,3	792
Respiratório	-10,3	+3,3	+9,7	+11,2	+30,9	+27,7	+3,7	-9,2	-3,4	-11,2	-25,2	-27,2	625
Circulatório	-5,9	+2,1	-3,7	-5,9	-2,6	0,0	+4,9	+8,6	-0,8	+1,7	-1,3	+3,0	609
Infecciosas	+5,9	+11,2	+9,7	+13,2	+9,4	-2,9	-11,7	-14,5	-0,6	-4,3	-9,5	-6,0	431
Digestivo	-4,6	+0,3	-0,5	+1,2	+4,9	+0,3	-0,4	+1,7	+3,2	-0,5	+3,8	-9,4	418
Gravidez e parto	-5,4	-0,8	+8,5	+9,0	+4,3	+0,9	-6,0	-5,2	+1,0	-1,0	-0,7	-4,5	407
Geniturinário	-5,4	+0,6	-5,0	-5,5	-7,1	-10,7	-5,8	+3,1	+9,2	+10,3	+11,8	+4,4	373
Câncer	-1,9	+1,1	+1,6	-4,3	+2,1	-9,4	-4,6	-0,5	+6,9	+7,3	+8,7	-7,1	255
Saúde mental	+8,8	-8,6	-1,7	+4,3	-6,4	-5,4	+4,1	-1,5	+5,8	-5,1	+6,1	-0,2	253
Perinatal	+6,6	-0,1	+4,4	+7,5	-0,3	-1,1	-7,2	+1,8	-2,9	-9,8	+1,4	-0,3	210

■ 20% ou mais abaixo
 ■ 10 a 20% abaixo
 ■ 5 a 10% abaixo
 ■ 2 a 5% abaixo
 ■ menos de 2% (na média)
 ■ 2 a 5% acima
 ■ 5 a 10% acima
 ■ 10 a 20% acima
 ■ 20% ou mais acima

Cada linha é comparada com a sua própria média do ano. Azul: mês mais cheio que a média; laranja: mais vazio. Os 10 grupos que mais ocupam leito. Mesma base da página do calendário de ocupação.

O QUE O GRÁFICO MOSTRA

Cada linha é um grupo de doença (a primeira é a rede inteira); cada coluna, um mês de 2025. A célula mostra quanto aquele mês ficou acima (azul) ou abaixo (laranja) da média do ano do próprio grupo. Serve para saber quando reforçar equipe e leitos.

REGRA DE NEGÓCIO

Pacientes internados por dia em cada mês, comparados com a média do ano do mesmo grupo (0% = mês igual à média). Mesma base do calendário de ocupação. Cores: menos de 2% é "na média"; depois faixas de 2-5%, 5-10%, 10-20% e 20% ou mais. Aparecem os 10 grupos que mais ocupam leito.

PERGUNTAS QUE RESPONDE

P35 Qual o mês mais cheio da rede?	Maio: 5.250 internados por dia, 3,9% acima da média do ano (5.053).
P36 E o mês mais vazio?	Dezembro: 4.807 por dia (-4,9%). Janeiro também fica abaixo (-3,4%).
P37 Qual doença mais muda ao longo do ano?	Respiratório: de 455 por dia em dezembro a 818 em maio. Maio fica 30,9% e junho 27,7% acima da média.
P38 Quando reforçar a rede para o respiratório?	Fica acima da média de fevereiro a julho, com pico em maio e junho. Em março já está 9,7% acima.
P39 Alguma doença aperta em outra época?	Infecciosas de fevereiro a maio (+9,4% a +13,2%). Geniturinário (+9,2% a +11,8%) e câncer (+6,9% a +8,7%) de setembro a novembro.
P40 Qual doença é estável o ano todo?	Lesões e traumas: entre -4,7% e +3,1% da média (755 a 817 por dia).

PERGUNTA **Como cada número do GiroSUS é calculado?****O QUE É O GIROSUS**

GiroSUS é um painel de Power BI para planejamento da ocupação de leitos do SUS em Goiás, feito com dado oficial e mensal das internações (SIH/SUS). Não é uma ferramenta de gestão de leitos em tempo real.

USAMOS UMA FERRAMENTA DE LEITO?

Não. O GiroSUS não usa censo hospitalar, sistema de regulação nem cadastro de leitos. Ele mede o uso do leito a partir das internações pagas pelo SUS. O CNES (leitos cadastrados) só foi usado na exploração.

Fonte	SIH/SUS, publicado pelo DATASUS (Ministério da Saúde): arquivos mensais das internações pagas pelo SUS em Goiás. Público e gratuito.
Período guardado	Janeiro de 2021 a junho de 2026.
Do arquivo ao painel	2.286.755 registros → 2.235.030 internações novas (sem as AIHs de continuação) → 457.403 internações da safra 2025, as que alimentam o painel.
Recorte	O painel cobre todo o estado de Goiás. Goiânia é o destaque e entra como filtro dentro do painel estadual, porque olhar só a capital esconderia a dependência das outras cidades.

As 8 regras usadas em todos os gráficos**1 Leito-dia**

Soma dos dias que cada paciente ficou internado.

2 Safra 2025

Internações apresentadas para pagamento de jan a dez/2025.

3 Só internação nova

AIHs de continuação ficam fora para não contar a mesma internação duas vezes.

4 Tempo típico

Mediana de dias do mesmo procedimento em 2025; não é puxada por casos extremos.

5 Dias acima do típico

Dias internado menos o tempo típico; se ficou menos, conta zero.

6 Grupo de doença

Primeira letra do CID-10: J = Respiratório, I = Circulatório...

7 Valor pago

O que o SUS pagou pela internação; não é o custo real do hospital.

8 Internados no dia

Quem já tinha entrado e ainda não tinha saído naquele dia.

O QUE O GIROSUS NÃO FAZ

- O SIH chega com 1 a 2 meses de atraso: o painel mostra padrões e onde agir, não a vaga livre de hoje.
- Não mostra leito livre em tempo real.
- Valor pago pelo SUS é diferente do custo real do hospital.
- O SIH não traz o nome do hospital: ele aparece pelo código CNES e pelo município.

REGRAS DE NEGÓCIO

COMO LIDAMOS COM A DEFASAGEM

PERGUNTA

O SIH chega com 1 a 2 meses de atraso. Como o GiroSUS lida com isso?

1

Transparência

O painel mostra a data de corte e marca cada mês como fechado, em consolidação ou estimado. O gestor sempre sabe o que já está completo.

2

Decisão baseada em mês fechado

Os números principais, como os leitos presos além do típico e o simulador, usam a safra fechada. A defasagem não muda a decisão, só atrasa o mês mais recente.

3

Estimativa dos meses incompletos

O atraso da cobrança é estável: 65% das internações chegam no mesmo mês da alta e 99% em até 3 meses. Por isso dá para completar os meses recentes. Testado com 2025: no mês mais recente, erro de 8,4%, contra 29% olhando só o que chegou; um mês antes, erro de 2,7%. Isso aparece como “estimado”, com faixa de erro.

4

Atualização mensal

Todo mês o estimado vira real, e o painel mostra quanto errou (o placar de acerto). Opção de piloto: o hospital contratante pode mandar os dados dele do mês corrente, para ver o “agora” dele mesmo.

Gestão de custo com a defasagem

Custo estimado do mês = leitos-dia estimados × R\$ por leito-dia dos últimos 3 meses fechados, calculado por grupo de doença.

Por grupo e com meses recentes porque o R\$ por leito-dia é estável, mas não é fixo: em 2025 variou entre R\$ 361 e R\$ 427 por mês e subiu no segundo semestre. Uma média do ano inteiro puxaria o valor para trás. Testado com 2025: erro de 4,8% no mês mais recente (contra 32% olhando só o que chegou) e de 4,0% um mês antes.

SITUAÇÃO HOJE

Situação hoje: o painel usa a safra 2025 completa, com todos os meses fechados. A estimativa dos meses incompletos e do custo já foi testada com os dados de 2025; a marcação por mês e o placar de acerto entram quando o painel passar a ser atualizado todo mês.